

Pestaña 1

Embolia de líquido amniótico

1. Introducción y relevancia clínica

La **embolia de líquido amniótico (ELA)** —también llamada **síndrome anafilactoide del embarazo**— es una **reacción sistémica aguda, grave y potencialmente fatal**, causada por la **entrada de líquido amniótico, células fetales o detritos placentarios a la circulación materna**.

Aunque su incidencia es baja (**1 por cada 20.000–40.000 partos**), su **letalidad es alta (hasta 50–80%)**, y constituye junto a la hemorragia posparto y la eclampsia una **causa clásica de muerte materna inmediata**.

□ EUNACOM clásico:

“Paciente en trabajo de parto con disnea súbita, cianosis, hipotensión y paro cardiorrespiratorio, seguida de CID → Diagnóstico: embolia de líquido amniótico.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Mecanismo desencadenante

La ELA ocurre cuando líquido amniótico o restos fetales ingresan a la **circulación materna a través de las venas uterinas** debido a una **ruptura de las barreras feto-maternas**.

Esto puede suceder:

- Durante el parto vaginal o cesárea.
- En maniobras obstétricas invasivas.
- En desprendimiento placentario o trauma uterino.

Fisiopatología actual

Ya no se considera una embolia mecánica pura, sino una **reacción anafilactoide** con tres fases:

1. Fase inicial (hemodinámica):

- Vasoespasmo pulmonar → **hipertensión pulmonar aguda**.

- Colapso del ventrículo derecho → hipotensión sistémica.

2. Fase secundaria (cardiaca y hemorragia):

- Falla cardiaca izquierda y edema pulmonar.
- Activación masiva de la **coagulación intravascular diseminada (CID)**.

3. Fase final:

- Hemorragia uterina incontrolable.
- Shock y paro cardiorrespiratorio.

3. Factores de riesgo

Aunque puede ocurrir sin factores predisponentes, se han identificado algunos asociados:

Maternos	Obstétricos / Iatrogénicos
Edad >35 años	Trabajo de parto precipitado o prolongado
Multiparidad	Ruptura uterina o de membranas
Cesárea o parto instrumental	Desprendimiento prematuro de placenta
Polihidroamnios	Trauma uterino o manipulación obstétrica
Preeclampsia	Laceraciones cervicales o uterinas
Muerte fetal intrauterina	Amniocentesis o inducción con prostaglandinas

□ Sin embargo, la **ELA puede ocurrir en mujeres sin ningún factor de riesgo**, lo que la hace impredecible.

4. Momento de aparición

La ELA puede presentarse en tres contextos:

1. **Durante el trabajo de parto (70%)**
2. **Inmediatamente después del parto (11–20%)**
3. **En el posparto precoz (hasta 30 minutos postparto)**

Es muy raro que ocurra después de 48 horas del parto.

5. Cuadro clínico característico

Instalación súbita y catastrófica:

1. **Disnea y cianosis** (primer signo).
2. **Hipotensión severa o colapso circulatorio.**
3. **Convulsiones o pérdida de conciencia.**
4. **Paro cardiorrespiratorio (en minutos).**
5. Si sobrevive a la fase inicial → **sangrado incoercible por CID.**

Fases clínicas clásicas:

Fase	Manifestaciones principales
Fase I: respiratoria y cardiovascular	Disnea, cianosis, hipotensión, shock, paro cardíaco.
Fase II: hemorrágica	Hemorragia uterina masiva, incoagulable; CID.

Signos acompañantes:

- Bradicardia o sufrimiento fetal agudo.
 - Cianosis y agitación materna.
 - Tono uterino aumentado o atonía secundaria a shock.
 - Coagulopatía franca (sangrado en sitios de punción, epistaxis, hematomas).
-

6. Diagnóstico

Clínico (sospecha inmediata):

En toda puérpera o parturienta con:

- Colapso cardiorrespiratorio súbito.
- CID inexplicable.
- Ausencia de sangrado inicial evidente.

Exámenes complementarios (no demoran la conducta):

- **Gasometría:** hipoxemia y acidosis metabólica.
- **Hemograma y coagulación:** plaquetopenia, TP y TTPa prolongados, fibrinógeno bajo.
- **Radiografía / ecografía pulmonar:** edema agudo de pulmón.
- **Ecocardiografía:** disfunción biventricular aguda.
- **Confirmación post mortem:** restos fetales en capilares pulmonares (diagnóstico histológico).

□ En la práctica, el diagnóstico es **clínico de exclusión**, una vez descartadas causas más frecuentes de colapso (TEP, anafilaxia, eclampsia, shock séptico).

7. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias principales
Tromboembolismo pulmonar	Historia de trombosis previa, cuadro menos súbito.
Anafilaxia	Antecedente de exposición a fármaco o alérgeno.
Eclampsia	Hipertensión y proteinuria previas, sin coagulopatía inicial.
Shock séptico	Fiebre, signos infecciosos.
Infarto agudo del miocardio	Dolor torácico típico, sin CID.

8. Manejo inicial y tratamiento de urgencia

A. Principios generales

1. **Sospecha inmediata** → actuar sin demora.
 2. **Reanimación avanzada materna.**
 3. **Mantener oxigenación y perfusión.**
 4. **Controlar coagulopatía.**
 5. **Resolver embarazo si no se ha producido el parto.**
-

B. Soporte vital inmediato

1. **Vía aérea y oxígeno:**

- Oxígeno al 100% (mascarilla o intubación).
- Si paro respiratorio → ventilación mecánica.

2. **Circulación:**

- Iniciar **RCP avanzada si paro**.
- **Cristaloides tibios y vasopresores** (noradrenalina, dopamina).
- Monitoreo invasivo si disponible.

3. **Control de coagulopatía (CID):**

- Plasma fresco congelado 15–20 mL/kg.
- Plaquetas si $<75.000/\mu\text{L}$.
- Crioprecipitado si fibrinógeno $<200\text{ mg/dL}$.
- Evitar sobrecarga de volumen.

4. **Anticonvulsivantes:** solo si convulsiones, siguiendo esquema de sulfato de magnesio.

5. **Evitar uterotónicos que agraven hipertensión pulmonar** (como ergometrina).

C. Manejo obstétrico

● **Si feto aún in útero y viable:**

- **Cesárea perimortem inmediata** (dentro de 4–5 minutos tras paro).
- Mejora perfusión materna y posibilidad de sobrevivencia fetal.

● **Si parto ya ocurrió:**

- Mantener masaje uterino y control de hemorragia (atonía o CID).
- Oxitocina EV + compresión bimanual.

□ Si la paciente colapsa durante el parto, **continuar reanimación sin suspender maniobras obstétricas**.

9. Manejo en unidades de cuidados intensivos (UCI)

- Ventilación mecánica con soporte hemodinámico.
- Control estricto de balance hídrico.
- Tratamiento de la coagulopatía.
- Vigilancia de disfunción multiorgánica (renal, hepática, neurológica).
- Alta tasa de síndrome postparo o daño neurológico.

10. Pronóstico

- **Mortalidad materna:** 40–80%.
- **Mortalidad fetal:** 20–60%.
- Pronóstico mejor si el diagnóstico y reanimación ocurren en **<5 minutos**.

Secuelas

- CID y shock pueden dejar daño renal, hepático o neurológico.
- Requiere apoyo psicológico posterior.

11. Prevención

No existe una medida preventiva específica, ya que la ELA es impredecible.

Sin embargo, se recomienda:

- Evitar maniobras obstétricas bruscas o instrumentales innecesarias.
- Monitoreo estrecho en partos de alto riesgo (preeclampsia, placenta previa, polihidroamnios).

- Preparación del equipo para emergencias obstétricas.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. ELA = **colapso cardiorrespiratorio súbito + CID** en contexto de parto.
2. **No es una embolia “tromboembólica”, sino una reacción anafilactoide.**
3. Primer signo: **disnea súbita seguida de hipotensión.**
4. **Tratamiento:** soporte vital avanzado, oxígeno, líquidos, vasopresores, transfusiones.
5. **Cesárea perimortem** si feto viable y paro materno.
6. **Evitar uterotónicos vasoconstrictores (metilergometrina).**



Errores comunes

- Confundir con tromboembolismo pulmonar (instalación más progresiva).
 - Esperar exámenes para confirmar diagnóstico.
 - No realizar RCP obstétrica inmediata.
 - No administrar plasma ni plaquetas ante CID.
 - No considerar cesárea perimortem.
-

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Embolia de líquido amniótico:** ingreso de material amniótico a la circulación materna → reacción anafilactoide.
2. **Inicio súbito:** disnea, hipotensión, shock, paro cardiorrespiratorio.
3. **Diagnóstico clínico:** sospecha ante colapso periparto + CID.
4. **Tratamiento:** soporte vital avanzado + transfusión dirigida + cesárea perimortem si feto viable.
5. **Evitar metilergometrina y sobrecarga de volumen.**
6. **Alta mortalidad:** >50% incluso con tratamiento.
7. **Prevención:** vigilancia en partos de riesgo y respuesta inmediata del equipo obstétrico.